



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
RS PRIMA HUSADA MALANG**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan TB DOTS Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Tim TB DOTS ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2017. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Tim TB DOTS ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 02 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestanti,M.Kes



LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor : 571.98/I-PDM/TB/VI/2025

Tentang

Pedoman Pelayanan Tuberkulosis (TB)
Dengan Strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shorcourse Chemotherapy)

Disusun oleh :

Ketua Tim HIV/AIDS RS Prima Husada Malang

dr.Andy,Sp.P

Disetujui oleh :

Authorized Person

Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP

Ditetapkan oleh :

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestanti, M.Kes



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Ruang Lingkup Pelayanan	1
1.3 Batasan Operasional	1
1.4 Landasan Hukum	1
BAB II STANDAR KETENAGAAN	3
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia	3
2.2 Distribusi Ketenagaan	3
2.3 Pengaturan Jaga	3
BAB III STANDAR FASILITAS	4
3.1 Denah Ruangan	4
3.2 Standar Fasilitas	5
3.3 Standart Peralatan Dan Pelaporan Tb Dots 5	5
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	Error! Bookmark not defined.
BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN PENANGGULANGAN TB	Error! Bookmark not defined.
BAB VI LOGISTIK	18
6.1 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Paket	18
6.2 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Non Paket	18
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	20
7.1 Pengertian	20
7.2 Tujuan	20
7.3 Standar Pasien Safety	20
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	21
8.1 Definisi	21
8.2 Tujuan	21
8.3 Tata Laksana Keselamatan Karyawan	21
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	22
9.1 Pasien Rawat Inap Tuberkulosis Yang Ditangani Strategi DOTS	22
9.2 Pencatatan Dan Pelaporan Tb Di Rumah Sakit	22
BAB X PENUTUP	24



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola ketenagaan TIM TB-DOTS Di Rumah Sakit Prima Husada.	3
Tabel 3.1 Alat keperawatan diruang klinik TB DOTS RS.Prima Husada	5
Tabel 3.2 Standar Peralatan Dan Pelaporan Tb 5 Di ruang rawat inap.....	5
Tabel 3.3 Standart Peralatan dan Pelaporan TB di Laboratorium.....	6
Tabel 5.1 Obat Anti Tuberkolosisi (OAT).....	11
Tabel 5.2 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori	13
Tabel 5.3 Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori.....	13
Tabel 5.4 Dosis KDT untuk Sisipan	13
Tabel 5.5 Sistem skoring (scoring system) gejala dan pemeriksaan penunjang TB.....	15
Tabel 5.6 OAT anak yang biasa dipakai dosisnya	15
Tabel 5.7 Dosis OAT Kombipak pada anak	17
Tabel 5.8 Dosis OAT KDT pada anak.....	17
Tabel 5.7 Pasien Rawat Inap Tuberkulosis Yang Ditangani Dengan Strategi DOTS....	22
Tabel 5.8 Pencatatan Dan Pelaporan TB Di Rumah Sakit.....	22



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR: 571.98/I-PDM/TB/VI/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN TUBERKULOSIS (TB) DENGAN STRATEGI DOTS (DIRECTLY OBSERVED TREATMENT, SHORCOURSE CHEMOTHERAPY)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengendalian tuberkulosis yang berkualitas secara berkesinambungan, perlu disusun dokumen perencanaan
 - Pedoman pengendalian tuberkulosis dalam bentuk Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan direktur tentang kebijakan Pengendalian Tuberkulosis;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/ SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
 - Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang Pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 - Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TUBERKULOSIS (TB) DENGAN STRATEGI DOTS (DIRECTLY OBSERVED TREATMENT, SHORCOURSE CHEMOTHERAPY)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

(1) Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit



menular yang disebabkan oleh *Myobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya;

- (2) Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negative yang ditimbulkan akibat tuberkulosis;
- (3) Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan kepdirjen Nomor Hk.02.02/d/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;
- (4) Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan TB dengan strategi DOTS;
- (2) Direktur Rumah Sakit menetapkan Tim TB/DOTS melalui Surat Keputusan Direktur;
- (3) Tim TB/DOTS memiliki program kerja tahunan, indikator mutu, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program TB;
- (4) Susunan organisasi Tim TB/DOTS sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab program TB;
 - b. Ketua Tim TB/DOTS;
 - c. Dokter pelaksana pelayanan TB;
 - d. Perawat pengelola program TB;
 - e. Petugas laboratorium TB;
 - f. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
 - g. Petugas pencatatan dan pelaporan;
 - h. Perwakilan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - i. Penanggung jawab program TB;
 - j. Ketua Tim TB/DOTS;
 - k. Dokter pelaksana pelayanan TB;
 - l. Perawat pengelola program TB;
 - m. Petugas laboratorium TB;
 - n. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
 - o. Petugas pencatatan dan pelaporan;
 - p. Perwakilan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- (5) Tim TB Paru Rumah Sakit bekerja sesuai wewenang masing-masing berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3

Tata Hubungan Kerja



- (1) Tim TB bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Direktur Rumah Sakit memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, sarana, prasarana, dan pembiayaan program TB;
- (3) Tim TB menyampaikan laporan kegiatan, capaian indikator, dan hasil monitoring evaluasi secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit;
- (4) Tim TB berkoordinasi dengan unit Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Inap, Laboratorium, Instalasi Farmasi, dan Tim PPI.

BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit menyediakan ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi TB ;
 - a. Area skrining TB;
 - b. Ruang pelayanan rawat jalan TB.;
 - c. Ruang konsultasi dan edukasi pasien TB;
 - d. Ruang pengambilan spesimen dahak;
 - e. Fasilitas laboratorium pemeriksaan TB.;
 - f. Ruang perawatan pasien TB sesuai kemampuan rumah sakit;
 - g. Sarana pencatatan dan pelaporan TB;
 - h. Fasilitas pencegahan dan pengendalian infeksi TB;
- (2) Rumah Sakit memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis paru dewasa, maka Rumah Sakit harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi TB;
- (3) Rumah sakit menerapkan pengendalian infeksi TB melalui;
 - a. Pengendalian administratif;
 - b. Pengendalian lingkungan;
 - c. Penggunaan alat pelindung diri;
- (4) Rumah sakit wajib menyediakan peralatan yang mendukung pelayanan TB sesuai kemampuan pelayanan, meliputi:
 - a. Peralatan pemeriksaan klinis;
 - b. Peralatan laboratorium TB;
 - c. Peralatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan;
 - d. Peralatan pendukung edukasi pasien.;
 - e. Peralatan pengendalian infeksi.

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN PENANGGULANGAN TB

Pasal 5

Pelaksanaan Pelayanan Penaggulangan TB



- (1) Rumah sakit menerapkan regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di Rumah Sakit;
- (2) Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Promosi kesehatan;
 - b. Surveilans TB;
 - c. Pengendalian faktor resiko;
 - d. Penemuan dan penanganan kasus TB;
 - e. Pemberian kekebalan;
 - f. Pemberian obat pencegahan;
- (3) Direktur menetapkan Tim TB paruh waktu rumah sakit beserta program kerjanya.

Pasal 6

Promosi Kesehatan

- (1) Promosi Kesehatan dalam penanggulangan TB ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program;
 - c. Memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di Rumah sakit;
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan Rumah sakit;
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.

Pasal 7

Surveilans TB

- (1) Surveilans TB Rumah sakit melakukan pemantauan dan analisis secara terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien;
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian;
- (3) Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program penanggulangan TB;
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resisten obat.



Pasal 8

Pengendalian Faktor Resiko

- (1) Pengendalian factor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB;
- (2) Pengendalian factor risiko TB dilakukan dengan cara;
 - a. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Membudayakan perilaku etika batuk
 - c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan rumah sesuai dengan standar;
 - d. Peningkatan daya tahan tubuh
 - e. Penanganan penyakit penyerta TB;
 - f. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB difasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Penemuan dan penanganan kasus TB

- (1) Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif;
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan melalui :
 - a. Investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko;
 - c. Skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- (4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB;
- (5) Penanganan kasus dalam penanggulangan TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan pengobatan pasien;
- (6) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengobatan dan penanganan efek samping difasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. Pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan.

PASAL 10

Pemberian Kekebalan

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka penanggulangan tb dilakukan melalui imunisasi bcg terhadap bayi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi resiko tingkat keparahan tb;
- (2) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



PASAL 11

Pemberian Obat Pencegahan

- (1) Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada :
 - a. Anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif:
 - b. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB:
 - c. Populasi tertentu lainnya.

BAB V

PANDUAN PRAKTIK KLINIS TB

PASAL 12

Panduan Praktik Klinis TB

- (1) Rumah sakit menetapkan kepatuhan staf medis terhadap panduan praktik klinis TB:
- (2) Rumah sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan obat anti TB:
- (3) Rumah sakit melaksanakan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit rujukan TB MDR):
- (4) Rumah sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus Tb Paru sesuai ketentuan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 02 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.98/I-PDM/TB/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN TB DENGAN
STRATEGI DOTS (TUBERKULOSIS
DIRECTLY OBSERVED TREATMENT,
SHORCOURSE CHEMOTHERAPY)

PEDOMAN PELAYANAN TB DENGAN STRATEGI DOTS
(TUBERKULOSIS DIRECTLY OBSERVED TREATMENT, SHORCOURSE
CHEMOTHERAPY)
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu penyakit Tuberkulosis oleh masyarakat dikenal sebagai penyakit menular dan merupakan salah satu masalah utama kesehatan di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penderita tuberkulosis yang ditemukan di masyarakat dan kematian yang disebabkan.

Pada tahun 1995, puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan di masyarakat dengan menerapkan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course). Dengan berjalannya waktu strategi DOTS telah mulai dikembangkan di Balai Pengobatan Paru-Paru dan di Rumah Sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.

Pada tahun 2004 survey prevalensi tuberkulosis menunjukkan bahwa pola pencarian pengobatan tuberkulosis ke rumah sakit ternyata cukup tinggi, yaitu sekitar 60 %. Pasien tuberkulosis ketika pertama kali sakit mencari pengobatan ke rumah sakit. Melihat dari besarnya animo masyarakat mencari pengobatan tuberkulosis ke rumah sakit, maka rumah sakit Prima Husada membuka pelayanan klinik TB DOTS yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini adalah dinas kesehatan kabupaten Malang.

1.2 Ruang Lingkup Pelayanan.

Ruang lingkup pelayanan Tuberkulosis di Rumah Sakit Prima Husada adalah

- Penjaringan pasien tuberkulosis,menegakkan diagnosa dan pengobatan.
- Pencatatan dan pelaporan pasien tuberkulosis.
- Menginformasikan dan atau mengirim pasien ke unit TB DOTS puskesmas atau rumah sakit lain.
- PKRS berfungsi sebagai pelaksana penyuluhan TB DOTS di rumah sakit.

1.3 Batasan Operasional.

Batasan operasional dalam pelayanan Tuberkulosis adalah memberi asuhan keperawatan kepada pasien tuberkulosis.

1.4 Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/ SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang Pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;



BAB II STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

Kualifikasi sumber daya manusia yang ada dalam pelayanan TB DOTS Rumah Sakit Prima Husada :

No	Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi KEMENKES			
		Standar	ACLS (wajib)	PPI (wajib)	TB DOTS (wajib)	KE (wajib)
1.	Ketua Tim TB DOTS : dr. Andy, Sp.P	Dokter Spesialis	V	V	V	V
2.	Ns.Tika Aryuni Damayanti , S.Kep	S1	V	V	V	V
3.	Oktavia Amelia Sari Amd.Kep	D3	V	V	V	V
4.	dr.Elvi,Sp.P-ONK	Dokter Spesialis	V	V	V	V
5.	dr.Fiona Paramitha,Sp.A	Dokter Spesialis	V	V	V	V
6.	Apt. Dita Ariesa Putri Prajoko S.Farm	S1	-	V	V	V
7.	Elis Wahyuni,Amd.Ak	D3	-	V	V	V
8.	Tuti Dwi jayati, Amd.Keb,SE	D3	-	V	V	V
9	Ery Santoso, S. Kep. Ns.	S1	V	V	V	V
10	Ns. Isa Ariyanti,S.Kep	S1	V	V	V	V
11	Afni Nur Ainy, S.Kep,Ns	S1	V	V	V	V
12	Murwani Suryaning Sapartinah, S.Kep, Ns	S1	V	V	V	V
13	Isma Maulida Mufida, Amd.Rad	D3	-	V	V	V

2.2 Distribusi Ketenagaan

Untuk distribusi ketenagaan di setiap instalasi ada satu orang koordinator dan bergabung dalam tim TB DOTS.Untuk waktu kerja masing-masing koordinator ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing instalasi dimana petugas / tim TB DOTS bekerja.

2.3 Pengaturan Jaga

Jam dinas:

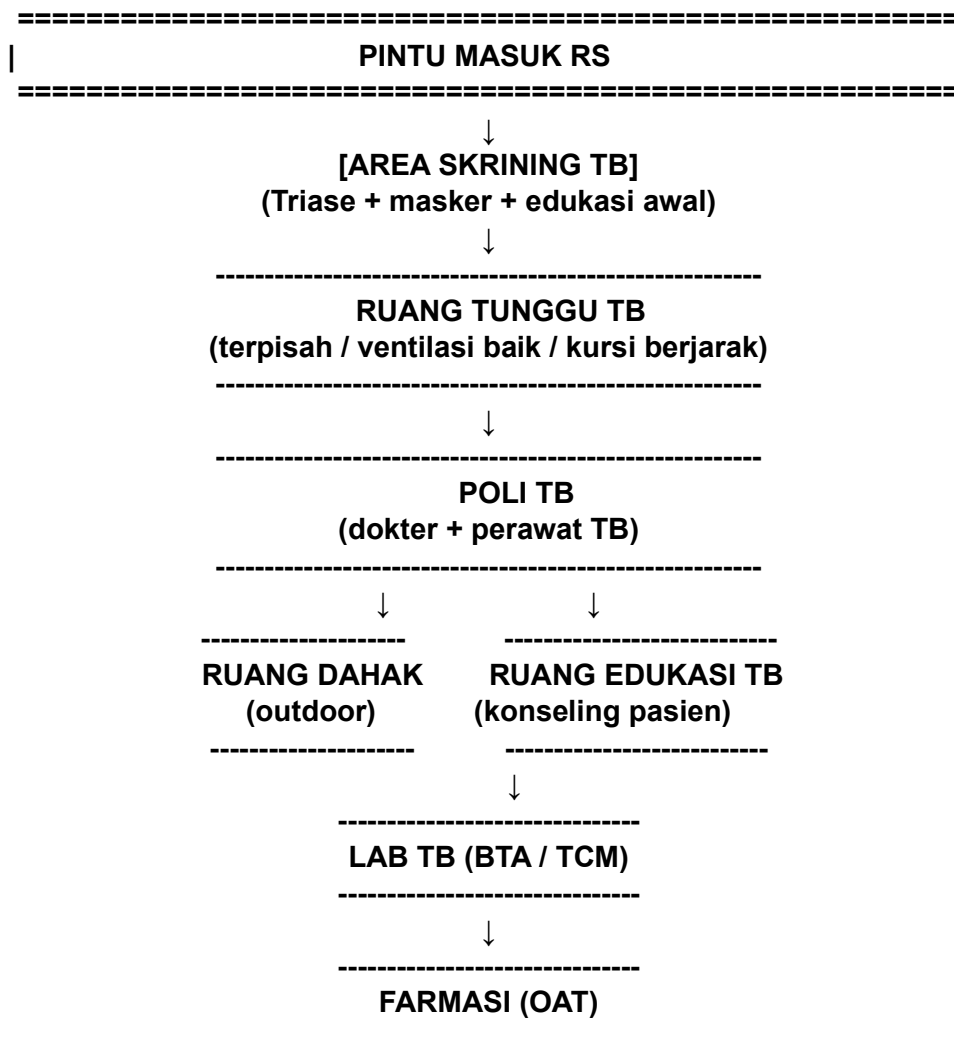
1. Dinas Pagi : 06.30-14.00
2. Dinas Siang : 14.00-21.00
3. Dinas Malam : 21.00-07.00
4. Dokter spesialis paru (terjadwal).
5. Tenaga perawat siap melayani kasus TB (terjadwal).



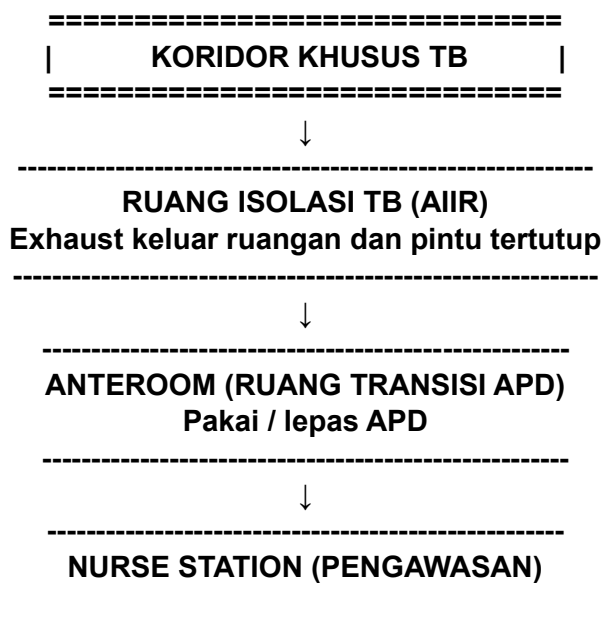
BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruangan

1. Denah Rawat Jalan Pelayanan TB



2. Denah Rawat Inap (Isolasi TB)





3.2 Standart Fasilitas

1. Ruang wajib

- a. Mempunyai ruangan untuk skrining TB;
- b. Mempunyai poliklinik TB (rawat jalan);
 - 1) Area terpisah dari poli umum.
 - 2) Mempunyai ventilasi yang baik
 - 3) Jalur pasien TB jelas (tidak bercampur).
- c. Terdapat ruang pengambilan dahak yang berada di depan poliklinik TB;
 - 1) Ruangan terpisah dari ruang tunggu.
 - 2) Mempunyai ventilasi yang baik (alami atau exhaust fan).
 - 3) Ruangan terbuka / semi terbuka.
 - 4) Tersedia tempat cuci tangan.
- d. Laboratorium yang terdesia mikroskop dan tes TCM;
- e. Adanya ruang isolasi TB (rawat inap);
 - 1) Tekanan negatif.
 - 2) Exhaust keluar gedung (tidak resirkulasi).
 - 3) Pintu ruangan selalu tertutup.
 - 4) Terdapat APD bagi tenaga kesehatan (N95).
- f. Farmasi untuk penyimpanan obat TB (OAT).

3.3 Standart Peralatan Dan Pelaporan Tb Dots Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Prima Husada.

1. Alat keperawatan diruang klinik TB DOTS RS.Prima Husada

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	MEJA	2
2	KURSI	5
3	TEMPAT TIDUR PERIKSA PASIEN	0
4	RAK ARSIP	1
5	BOX X-RAY	1
6	STETOSKOP	1
7	TENSIMETER	1
8	BUKU PELAPORAN TB	0
9	MASKER	1BOX
10	TIMBANGAN BADAN	1
11	FOOT STEP	0
12	KIPAS ANGIN	2

2. Standar Peralatan Dan Pelaporan Tb Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Prima Husada.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	RUANG ISOLASI	2
2	TEMPAT TIDUR PASIEN	2
3	MEJA PASIEN	2
4	KURSI	2
5	OKSIGEN	2
6	BUKU PELAPORAN TB	0



3. Standart Peralatan dan Pelaporan TB di Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	MIKROSKOP BTA	1
2	MIKROSKOP TCM	0
3	OBJEK GLASS	1 BOX
4	RAK PENGERING	1
5	RAK PEWARNA	1
6	BUNSEN	1
7	OSE	1 BOX
8	PIPET PEWARNA	1
9	HEMOSTAT / PENJEPIT	1
10	OBJEK GLASS	1 BOX
11	LIDI	1 BOX
12	KOREK	1
13	REAGEN ZIEHL NEELSEN	1
14	BUKU PELAPORAN	2 (TB 04,TB 05)



BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN

1. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan TB dengan strategi DOTS
2. Tersedia pelayanan TB dengan strategi DOTS pada mutu dan keselamatan pasien.
3. Tersedia ruang pelayanan TB DOTS rawat jalan dan rawat inap.
4. Pasien baru dengan suspek TB wajib periksa sputum TCM. Jika hasil negatif maka lakukan rontgent. Bila hasil positif maka langsung dilakukan pengobatan.
5. Pada pasien suspek TB dengan TCM positif, dan di akhir fase intensif hasil masih positif, maka pasien tersebut adalah suspek MDR (Multi Dark Resisten) dan lakukan rujukan ke pelayanan kesehatan yang menerima pasien suspek MDR.
6. Rumah sakit masih belum memiliki alat sendiri untuk pengecekan sputum dahak TCM karna terbatasnya alat yang di sediakan dari dinas Kesehatan dan saat ini sputum dahak TCM kita kirim ke puskesmas jejaring terdekat.
7. Tersedianya ruangan pengambilan spesimen sputum dahak
8. Pendaftaran menyediakan masker untuk pasien dengan penderita batuk.
9. Petugas melakukan pendidikan batuk yang benar
10. OAT (Obat Anti Tuberkulosis) di dapat dari kerjasama dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Malang dengan melakukan pelaporan pasien dengan kejadian Tuberkulosis.
11. Petugas wajib memantau perkembangan pasien sampai pasien dinyatakan sembuh.
12. Setiap petugas wajib mendukung terlaksananya pelayanan TB dengan strategi DOTS. dan apabila pasien/keluarga menolak dan keberatan, maka wajib dimintakan persetujuan penolakan tindakan.



BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan tuberkulosis berupa upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tuberkulosis. Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis melakukan kegiatan yang meliputi:

1. Promosi kesehatan
yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, penobatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran yaitu pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit.
2. Surveilans tuberkulosis
merupakan kegiatan memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis, seperti pencatatan dan pelaporan tuberkulosis sensitif obat, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis resistensi obat.
3. Pengendalian faktor risiko tuberkulosis
ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit
pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit.
4. Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis.
Penemuan kasus tuberkulosis dilakukan melalui pasien yang datang kerumah sakit, setelah pemeriksaan, penegakan diagnosis, penetapan klarifikasi dan tipe pasien tuberkulosis. Sedangkan untuk penanganan kasus dilaksanakan sesuai tata laksana pada pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian kekebalan
Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG terhadap bayi dalam upaya penurunan risiko tingkat pemahaman tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian obat pencegahan.
Pemberian obat pencegahan selama 6 (enam) bulan yang ditujukan pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif; orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosis tuberkulosis; populasi



tertentu lainnya sesuai peraturan perundang- undangan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut maka rumah sakit dapat membentuk tim/panitia pelaksana program TB Paru Rumah Sakit.

A. Konsep Pelayanan Secara Umum.

Penatalaksanaan TB meliputi penemuan pasien dan pengobatan yang di kelola dengan menggunakan strategi TB DOTS. Tujuan utama pengobatan pasien TB adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan serta mencegah penularan dengan cara menyembuhkan pasien.

1. Dilakukan secara kerjasama tim (teamwork) dokter, perawat danfarmasi, Laboratorium,serta melibatkan tenaga kesahatan lain yaitu gizi dan pendaftaran.
2. Pelayanan dilakukan sesuai standar asuhan keperawatan.
3. Peralatan yang tersedia memenuhi ketentuan undang-undang.
4. Semua tindakan terdokumentasikan dengan baik.
5. Harus ada sistem monitor dan evaluasi.
6. Penemuan pasien TB dilakukan secara pasif dengan promosi aktif.
7. Penjaringan tersangka pasien TB dilakukan di unit pelayanan.
8. Pemeriksaan terhadap kontak pasien TB terutama mereka yang BTA positif,yang menunjukkan gejala sama,harus diperiksa dahaknya.

B. Diagnosis TB Paru

1. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu *sewaktu-pagi-sewaktu (SPS)*.
2. Diagnosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB melalui pemeriksaan dahak : TCM/BTA. Pemeriksaan lain seperti foto thoraks, biakan dan uji kepekaan dapat juga sebagai penunjang diagnosis sesuai dengan indikasinya.
3. Tidak dibenarkan mendiagnosa TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto thorax saja. Foto Thorax saja tidak memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdosis.
4. Gambaran kelainan radiologik tidak selalu menunjukan aktivitas penyakit.
Diagnosis TB ekstra paru
5. Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk, nyeri dada pada TB pleura, pembesaran kelenjar limfe
6. Diagnosis pasti sering sulit ditegakan, sedangkan diagnosis kerja dapat ditegakan berdasarkan gejala klinik TB yang kuat dengan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Ketepatan diagnosis tergantung pada metode pengambilan bahan pemeriksaan dan ketersediaan alat-alat diagnostik, misalnya uji mikrobiologi, patologi anatomi, serologi, foto thorax, dll.
7. Indikasi pemeriksaan foto thorax Pada sebagian besar TB paru, diagnosis terutama ditegakan denngan pemeriksaan dahak secara mikroskopik dan tidak



memerlukan foto thorax. Namun pada kondisi tertentu pemeriksaan foto thoraxs perlu dilakukan sesuai dengan indikasi sebagai berikut :

8. Hanya 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif.
Pada kasus ini pemeriksaan foto thorax dada diperlukan untuk mendukung diagnosis TB paru BTA positif
9. Ke tiga spesimen dahak hasilnya tetap negatif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hanya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT.
10. Pasien tersebut diduga mengalami komplikasi sesak nafas berat yang memerlukan penanganan khusus.



C. Pengobatan TB Paru

Tujuan Pengobatan

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT.

1. Jenis, sifat dan dosis OAT

Tabel 1. Jenis, sifat dan dosis OAT

Jenis	Sifat	Efek Samping
Isoniazid (H)	Bakterisidal	Neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan fungsi hati, kejang
Rifampisin(R)	Bakterisidal	Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skinrash, sesak nafas, anemia hemolitik
Pirazinami d(Z)	Bakterisidal	Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, goutarthritis
Streptomisi n(S)	Bakterisidal	Nyeri ditempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia, agranulositosis, trombositopeni
Etambutol(E)	Bakteriostatik	Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer

2. Prinsip pengobatan

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:

- OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT – KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.
- Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT = *Directly Observed Treatment*) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).
- Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.
 - Tahap awal (intensif)
 - ❖ Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat.



- ❖ Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu.
- ❖ Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.
- ii. Tahap Lanjutan
 - ❖ Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama
 - ❖ Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman *persister* sehingga mencegah terjadinya kekambuhan
- 3. Paduan OAT yang digunakan di Indonesia
 - a. Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia:
 - ❖ Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3.
 - ❖ Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3.

Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan (HRZE) Kategori Anak: 2HRZ/4HR Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT), sedangkan kategori anak sementara ini disediakan dalam bentuk OAT kombipak.

Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien.

- a. Paket Kombipak.

Terdiri dari obat lepas yang dikemas dalam satu paket, yaitu Isoniasid, Rifampisin, b. Pirazinamid dan Etambutol.

Paduan OAT ini disediakan program untuk mengatasi pasien yang mengalami efek samping OAT KDT.

4. Paduan OAT dan peruntukannya.

- a. Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3)
 - ❖ Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:
 - ❖ Pasien baru TB paru BTA positif.
 - ❖ Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif
 - ❖ Pasien TB ekstra paru



Tabel 2. Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)
30 – 37 kg	2 tablet 4KDT	2 tablet 2KDT
38 – 54 kg	3 tablet 4KDT	3 tablet 2KDT
55 – 70 kg	4 tablet 4KDT	4 tablet 2KDT
≥ 71 kg	5 tablet 4KDT	5 tablet 2KDT

b. Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya:

1. Pasien kambuh
2. Pasien gagal
3. Pasien dengan pengobatan setelah *default* (terputus)

Tabel 3. Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori 2

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari RHZE (150/75/400/275) + S		Tahap Lanjutan 3 kali seminggu RH (150/150) + E(275)
	Selama 56 hari	Selama 28 hari	selama 20 minggu
30–37 kg	2 tab 4KDT + 500 mg Streptomisin inj.	2 tab 4KDT	2 tab 2KDT + 2 tab Etambutol
38–54 kg	3 tab 4KDT + 750 mg Streptomisin inj.	3 tab 4KDT	3 tab 2KDT + 3 tab Etambutol
55–70 kg	4 tab 4KDT + 1000 mg Streptomisin inj.	4 tab 4KDT	4 tab 2KDT + 4 tab Etambutol
≥ 71 kg	5 tab 4KDT + 1000mg Streptomisin inj.	5 tab 4KDT	5 tab 2KDT + 5 tab Etambutol

Catatan:

Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk streptomisin adalah 500mg tanpa memperhatikan berat badan. Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus. Cara melarutkan streptomisin vial 1gram yaitu dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml. (1ml = 250mg)

c. OAT Sisipan (HRZE)

Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari).

Tabel 4. Dosis KDT untuk Sisipan

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari RHZE (150/75/400/275)
30 – 37 kg	2 tablet 4KDT
38 – 54 kg	3 tablet 4KDT
55 – 70 kg	4 tablet 4KDT
≥ 71 kg	5 tablet 4KDT



Penggunaan OAT lapis kedua misalnya golongan aminoglikosida (misalnya kanamisin) dan golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan kepada pasien baru tanpa indikasi yang jelas karena potensi obat tersebut jauh lebih rendah daripada OAT lapis pertama. Di samping itu dapat juga meningkatkan terjadinya risiko resistensi pada OAT lapis kedua.

Paduan OAT ini disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket untuk satu (1) pasien dalam satu (1) masa pengobatan. KDT mempunyai beberapa keuntungan dalam pengobatan TB:

- a. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin efektifitas obat dan mengurangi efek samping.
- b. Mencegah penggunaan obat tunggal sehingga menurunkan resiko terjadinya resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep
- c. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien

4. TATALAKSANA TB ANAK

Diagnosis TB pada anak sulit sehingga sering terjadi misdiagnosis baik *overdiagnosis* maupun *underdiagnosis*. Pada anak – anak batuk bukan merupakan gejala utama. Pengambilan dahak pada anak biasanya sulit, maka diagnosis TB anak perlu kriteria lain dengan menggunakan sistem skor. Unit Kerja Koordinasi Respirologi PP IDAI telah membuat Pedoman Nasional Tuberkulosis Anak dengan menggunakan sistem skor (*scoring system*), yaitu pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis yang dijumpai. Pedoman tersebut secara resmi digunakan oleh program nasional penanggulangan tuberkulosis untuk diagnosis TB anak.

Setelah dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, maka dilakukan pembobotan dengan sistem skor. Pasien dengan jumlah skor yang lebih atau sama dengan 6 (≥ 6), harus ditatalaksana sebagai pasien TB dan mendapat OAT (obat anti tuberkulosis). Bila skor kurang dari 6 tetapi secara klinis kecurigaan kearah TB kuat maka perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya sesuai indikasi, seperti bilasan lambung, patologi anatomi, pungsi lumbal, pungsi pleura, foto tulang dan sendi, funduskopi, CT-Scan, dan lain lainnya.

Tabel 5. Sistem skoring (*scoring system*) gejala dan pemeriksaan penunjang TB



Parameter	0	1	2	3	Jumlah
Kontak TB	Tidak jelas		Laporan keluarga, BTA negatif atau tidak tahu, BTA tidak jelas	BTA positif	
Uji tuberkulin	negatif			Positif (≥ 10 mm, atau ≥ 5 mm pada keadaan imunosupresi)	
Berat badan / keadaan gizi		Bawah garis merah (KMS) atau $BB/U < 80\%$	Klinis gizi buruk ($BB/U < 60\%$)		
Demam tanpa sebab jelas		≥ 2 minggu			
Batuk		≥ 3 minggu			
Pembesaran kelenjar limfe koli, aksila, inguinal		≥ 1 cm, jumlah > 1 , tidak nyeri			
Pembengkakan tulang / sendi panggul, lutut, falang		Ada pembengkakan			
Foto toraks toraks	Normal / tidak jelas		Suggestif TB		
Jumlah					

Tabel 6 OAT anak yang biasa dipakai dosisnya.

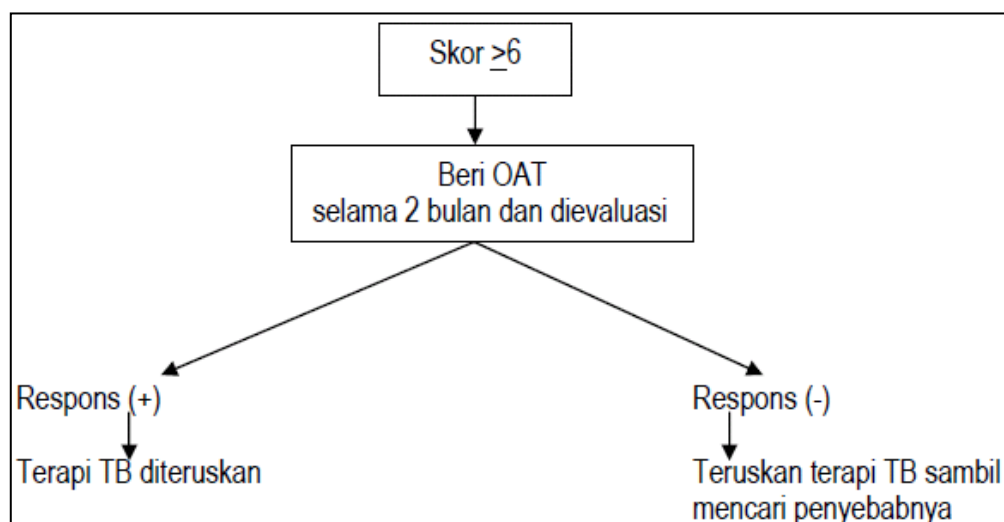
Nama Obat	Dosis harian (mg/kgBB/hari)	Dosis Maksimal (mg/hari)	Efek Samping
Isoniazid (H)	10(7-15)	300	Hepatitis, neuritis, perifer, hipersensitivitas
Rifampisin(R)	15(10-20)	600	Gastrointestinal, reaksi kulit, hepatitis, trombositopenia, peni ngkatan enzim hati, cairan tubuh berwarna orange kemerahan
Pirazinamid(P)	35(30-40)	-	Toksisitas hepar, artralgia, gastrointestinal
Etambutol(E)	20(15-25)	-	Neuritis optik, ketajaman mata berkurang, buta warna merah hijau hipersensitivitas, gastrointestinal.
Streptomisin(S)	15-40	1000	Ototoksik, nefrotoksik

Catatan :

- Diagnosis dengan sistem skoring ditegakkan oleh dokter.
- Batuk dimasukkan dalam skor setelah disingkirkan penyebab batuk kronik lainnya seperti Asma, Sinusitis, dan lain – lain.
- Jika dijumpai skrofuloderma (TB pada kelenjar dan kulit), pasien dapat langsung didiagnosis tuberkulosis.
- Berat badan dinilai saat pasien datang (*moment opname*).--> lampirkan tabel badan badan.
- Foto toraks toraks bukan alat diagnostik utama pada TB anak
- Semua anak dengan reaksi cepat BCG (reaksi lokal timbul < 7 hari setelah penyuntikan) harus dievaluasi dengan sistem skoring TB anak.
- Anak didiagnosis TB jika jumlah skor > 6, (skor maksimal 13)
- Pasien usia balita yang mendapat skor 5, dirujuk ke RS untuk evaluasi lebih lanjut.

Perlu perhatian khusus jika ditemukan salah satu keadaan di bawah ini:

- Tanda bahaya:
 - kejang, kaku kuduk
 - penurunan kesadaran
 - kegawatan lain, misalnya sesak napas
- Foto toraks menunjukkan gambaran milier, kavitas, efusi pleura
- Gibbus, koksitis



Gambar 2. Alur tatalaksana pasien TB anak pada unit pelayanan kesehatan dasar

Pada sebagian besar kasus TB anak pengobatan selama 6 bulan cukup adekuat. Setelah pemberian obat 6 bulan, lakukan evaluasi baik klinis maupun pemeriksaan penunjang. Evaluasi klinis pada TB anak merupakan parameter terbaik untuk menilai keberhasilan pengobatan. Bila dijumpai perbaikan klinis yang nyata walaupun gambaran radiologik tidak menunjukkan perubahan yang berarti, OAT tetap dihentikan.

Kategori Anak (2RHZ/4RH)

Prinsip dasar pengobatan TB adalah minimal 3 macam obat dan diberikan dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak.



Tabel 6. Dosis OAT Kombipak pada anak

Jenis Obat	BB < 10 kg	BB 10 – 20 kg	BB 20 – 32 kg
Isoniasid	50 mg	100 mg	200 mg
Rifampicin	75 mg	150 mg	300 mg
Pirasinamid	150 mg	300 mg	600 mg

Tabel 7. Dosis OAT KDT pada anak

Berat badan (kg)	2 bulan tiap hari RHZ (75/50/150)	4 bulan tiap hari RH (75/50)
5-9	1 tablet	1 tablet
10-19	2 tablet	2 tablet
20-32	4 tablet	4 tablet

Keterangan:

1. Bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg dirujuk ke rumah sakit
2. Anak dengan BB 15 – 19 kg dapat diberikan 3 tablet.
3. Anak dengan BB > 33 kg , dirujuk ke rumah sakit.
4. Obat harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah
5. OAT KDT dapat diberikan dengan cara : ditelan secara utuh atau digerus sesaat sebelum diminum.

Pengobatan Pencegahan (Profilaksis) untuk Anak

Pada semua anak, terutama balita yang tinggal serumah atau kontak erat dengan penderita TB dengan BTA positif, perlu dilakukan pemeriksaan menggunakan sistem skoring. Bila hasil evaluasi dengan skoring sistem didapat skor < 5, kepada anak tersebut diberikan Isoniazid (INH) dengan dosis 5 – 10 mg/kg BB/hari selama 6 bulan. Bila anak tersebut belum pernah mendapat imunisasi BCG, imunisasi BCG dilakukan setelah pengobatan pencegahan selesai.

5. Tata laksana TB MDR

TB MDR atau Multi Drugs – resistant Tuberculosis adalah jenis tuerkulosi yang kebal terhadap 2 obat anti TB paling kuat yaitu isoniazid dan rhipampisin

Kondisi ini lebih serius yang membutuhkan pengobatan lini ke 2 selama 9-24bulan, dann seringkali disebabkan oleh ketidakpatuhan atau penghentian pengobatan TB biasa sebelum waktunya

Di RS Prima Husada Malang tidak tersedia pelayanan dengan TB MDR dikarenakan keterbatasan obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan lebih difokuskan untuk RS besar area Kabupaten Malang seperti RSUMM dan di RSSA untuk daerah Kota Malang.

Apabila di RSPHM ditemukan dengan TB MDR maka akan dilakukan rujuk ke Rumah sakit rujukan.



BAB VI LOGISTIK

Kegiatan logistik Obat Anti Tuberkulosis dan Pot Dahak dalam pelayanan TB Rumah sakit Prima Husada merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi. Secara keseluruhan kebutuhan logistik baik obat maupun pot untuk specimen dahak

RS.Prima Husada masih mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten malang dan DFK Kabupaten Malang untuk pengambilan BHP dan mengisi form permintaan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pengadaan logistik untuk pelayanan DOTS dilakukan dengan mengajukan permintaan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sesuai kebutuhan.

6.1 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Paket

Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan OAT paket merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada dibawah Koordinator Farmasi DOTS.OAT paket terdiri dari :

- a. OAT KDT kategori 1
- b. OAT KDT kategori Anak
- c. OAT Kombipak Kategori 1

6.2 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Non Paket

Instalasi Farmasi juga menyediakan OAT non paket (generik atau paten), yang pengadaannya sesuai dengan belanja farmasi. Koordinator Farmasi mengajukan pemesanan OAT paket kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui Koordinator Rawat Jalan atau Koordinator DOTS.

1. Logistik Laboratorium

Pengadaan dan pengelolaan logistik Laboratorium berkaitan dengan DOTS (pemeriksaan BTA SPS) merupakan tanggung jawab Instalasi Laboratorium di bawah Koordinator laboratorium. Kebutuhan logistik laboratorium terkait DOTS terdiri dari :

- a. Objek glass
- b. Cat *Ziehl Neelsen*
- c. Pot sputum
- d. Box penyimpanan objek glass
- e. TB 04
- d. TB 06

Catatan : Pengadaan oleh Rumah Sakit Pruma Husaha Malang.

2. Logistik Dokumentasi

Logistik dokumentasi DOTS berkaitan dengan pencatatan pasien TB, meliputi :

- a. TB 01 (status pasien TB)
- b. TB 02 (kartu kontrol pasien)



- c. TB 04 (data pemeriksaan BTA – laboratorium) B 03 (buku besar DOTS RS)
- d. TB 05 (formulir permintaan pemeriksaan BTA)
- e. TB 06 (buku data suspek TB)
- f. TB 09 (form rujukan)

Catatan : Koordinator laboratorium mengajukan pemesanan logistik laboratorium kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.



BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1 Pengertian

Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu system dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman.

7.2 Tujuan.

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di RS
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan

7.3 Standart *Patient Safety*.

Standar keselamatan pasien (patient safety) untuk pelayanan klinik TB DOTS

Rawat inap dan rawat jalan adalah:

1. Ketepatan Identitas.
Target 100% label identitas dan penulisan identitas di buku register TB dots tepat.
2. Penulisan identitas pasien di resep Rawat Jalan yang jelas agar tepat obat, tepat pasien
3. Terpasang gelang identitas pasien rawat inap.
Target 100% pasien yang masuk ke rawat inap terpasang gelang identitas pasien dan advice sesuai diagnosa pasien.
4. Pelaksanaan SBAR. Target 100% konsul ke dokter via telpon menggunakan metode SBAR untuk pasien rawat inap.
6. Ketepatan penyampaian hasil pemeriksaan penunjang.
Target 100% yang dimaksud tidak tepat apabila : salah ketik hasil, mengetik terbalik dengan hasil lain, hasil tidak terketik, salah identitas. Yang nantinya akan mempengaruhi advice pengobatan.
7. Ketepatan pemberian obat.
Target 100% yang dimaksud tidak tepat apabila salah obat, salah dosis, salah jenis, kurang/kelebihan dosis, salah rute pemberian, salah identitas pada etiket, salah pasien yang dapat membahayakan keselamatan pasien.



BAB VIII KESELAMATAN KERJA

8.1 Definisi

Keselamatan kerja merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat kerja / aktifitas karyawan lebih aman. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan pribadi ataupun rumah sakit.

8.2 Tujuan.

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS. Prima Husada.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penularan penyakit.
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

8.3 Tata Laksana Keselamatan Karyawan.

1. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu :
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi.
 - b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kacamata, sepatu boot/alas kaki tertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll.
 - c. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah menangani pasien.
2. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius.
3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin.
 - b. Pencucian dengan sabun.
 - c. Pengeringan.



BAB IX PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan maupun pemeriksaan laboratorium agar hasil pemeriksaan tepat dan benar.

Pemantauan Mutu OAT.

Mutu OAT diperiksa melalui pemeriksaan pengamatan fisik obat yang meliputi :

- Keutuhan kemasan dan wadah.
- Penandaan/label termasuk persyaratan penyimpanan.
- Pengontrolan nomer batch dan tanggal kadaluarsa.

Pemantauan Mutu Laboratorium. Pada prinsipnya pemantauan mutu laboratorium berdasarkan standart pemeriksaan laboratorium.

1. Pasien Rawat Inap Tuberkulosis Yang Ditangani Dengan Strategi DOTS.

Judul	Pasien Rawat Inap Tuberkulosis Yang Ditangani Dengan Strategi DOTS.
Dimensi mutu	Akses, efisiensi
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien tuberkulosis dengan strategi DOTS
Definisi Operasional	Pelayanan rawat inap tuberkulosis dengan strategi DOTS adalah pelayanan tuberkulosis dengan 5 strategi penanggulangan tuberkulosis nasional. Penegakan diagnosis dan follow up pengobatan pasien tuberkulosis harus melalui pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis, pengeobatan harus menggunakan paduan obat anti tuberkulosis yang sesuai dengan standar penanggulangan tuberkulosis nasional, dan semua pasien yang tuberkulosis yang diobati dievaluasi secara kohort sesuai dengan
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah semua pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS
Denominator	Jumlah seluruh pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani di rumah sakit dalam waktu tiga bulan)
Sumber data	Register rawat inap, register TB 03 UPK
Standar	100 %
Penanggung jawab	Ketua komite mutu/tim mutu

2. Pencatatan Dan Pelaporan Tb Di Rumah Sakit

Judul	Pencatatan Dan Pelaporan Tb Di Rumah Sakit.
Dimensi mutu	Kesinambungan layanan, keselamatan
Tujuan	Ketertiban pencatatan dan pelaporan tuberkulosis dalam mendukung epidemiologi tuberkulosis
Definisi Operasional	Pencatatan sebagai bahan acuan dan dokumentasi
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan



Periode analisis	3 bulan
Numerator	12
Denominator	Jumlah Pencatatan dan pelaporan tuberculosis yang lengkap dan tepat waktu
Sumber data	Rekam medis pasien
Standar	$\geq 60\%$
Penanggung jawab	Ketua komite mutu/tim mutu



BAB X PENUTUP

Pada dasarnya pelayanan TB DOTS baik di rawat jalan maupun di rawat inap merupakan bagian pelayanan di rumah sakit Prima Husada tidak saja membutuhkan ketrampilan teknis medis ataupun asuhan keperawatan saja, tetapi unsur pengelolaan/manajemen pelayanan juga sangat mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini. Dimana masing-masing pihak terkait dapat memahami perannya yang selanjutnya akan melakukan pelayanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. telah disusun suatu Pedoman Pelayanan TB DOTS di rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai acuan untuk melaksanakan dan mengelola pelayanan kesehatan tuberkulosis di ruang lingkup Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 02 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini,M.Kes